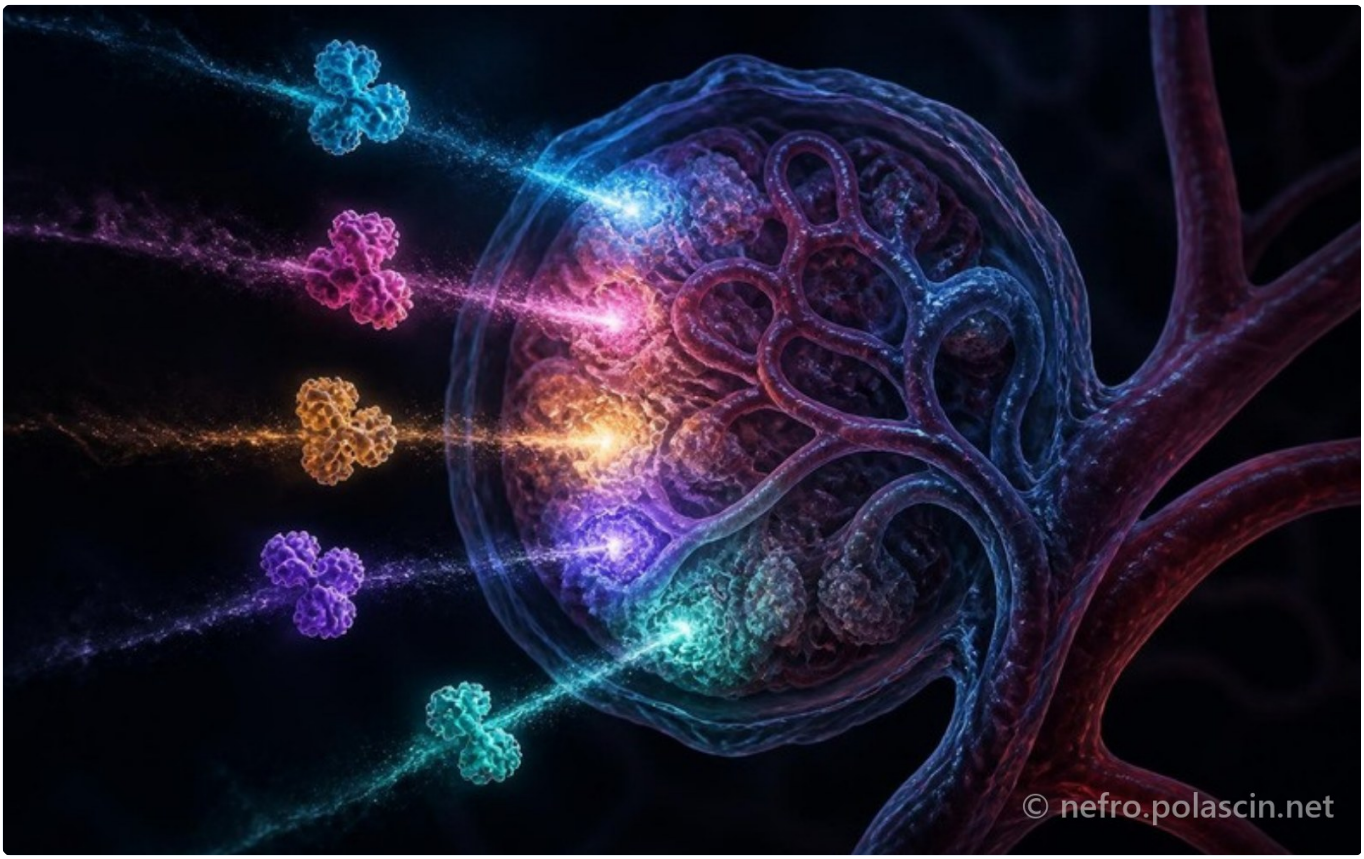
IgA nefropatia: nové poznatky prinášajú vlnu cielenej liečby

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Nové lieky nezasahujú na jednom mieste — každý mieri na inú časť toho istého procesu.

Čo je IgA nefropatia?

IgA nefropatia (IgAN), známa aj ako Bergerova choroba, predstavuje najčastejšiu primárnu glomerulonefritídu na svete. Napriek tomu, že ide o relatívne pomaly progredujúce ochorenie, stále zostáva významnou príčinou terminálneho zlyhania obličiek, ktoré si vyžaduje dialýzu alebo transplantáciu.

Patogenéza: „multi-hit“ hypotéza

V súčasnosti sa predpokladá, že rozvoj ochorenia prebieha v štyroch kľúčových krokoch:

1. Zvýšená produkcia galaktózo-deficientného IgA1 (Gd-IgA1).
2. Tvorba protilátok (najmä IgG) namierených proti tomuto abnormálnemu IgA1.
3. Vznik cirkulujúcich imunitných komplexov.
4. Ukladanie týchto komplexov v mezangiu obličiek, čo spúšťa zápal a fibrózu.

Zrýchlené schvaľovanie liekov podľa proteinúrie

V posledných rokoch došlo k zásadnému posunu v tom, ako regulačné úrady (FDA, EMA) pristupujú k hodnoteniu liekov. Proteinúria sa stala uznávaným náhradným cieľom (surrogate endpoint). Ak liek dokáže za rok významne znížiť vylučovanie bielkovín močom, možno predpokladať, že dlhodobo spomalí aj pokles funkcie obličiek.

Nové lieky v liečbe IgA nefropatie

Doterajšia liečba sa zameriavala najmä na kontrolu krvného tlaku pomocou ACE inhibítorov alebo sartanov. Dnes prichádzajú na scénu cielenejšie molekuly:

- **Sparsentan:** Duálny inhibítor endotelínových a angiotenzínových receptorov (DEARA).
- **Atrasentan:** Selektívny antagonista endotelínového receptora A.

- **Budesonid:** Cielené uvoľňovanie steroidu v oblasti Peyerových plakov v čreve na zníženie produkcie Gd-IgA1.

Iptacopan a údaje o zachovaní eGFR

Iptacopan je perorálny inhibítor faktora B v alternatívnej ceste komplementu. Štúdia APPLAUSE-IgAN ukázala, že u pacientov s IgA nefropatiou došlo k významnému zredukovaniu proteinúrie a údaje naznačujú priaznivý vplyv na stabilizáciu glomerulovej filtrácie (eGFR).

Sibeprenlimab: blokáda APRIL ako sľubný smer

Jedným z najprogresívnejších prístupov je blokáda cytokínu APRIL, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v aktivácii B-lymfocytov a produkcii IgA. Sibeprenlimab, monoklonálna protilátka proti APRIL, v štúdii ENVISION preukázal výrazné a dlhodobé zníženie proteinúrie aj hladín Gd-IgA1.

Prečo je skoršia diagnostika taká dôležitá?

Včasná detekcia pacientov s rizikom rýchlej progresie je kľúčová. Biopsia obličiek zostáva „zlatým štandardom“, avšak medzinárodné rizikové skóre (International IgAN Prediction Tool) nám pomáha identifikovať pacientov, ktorí by najviac profitovali z agresívnejšej modernej terapie.

Liečba bude čoraz viac individuálna

Budúcnosť nefrológie smeruje k personalizovanej medicíne. U niektorých pacientov môže dominovať aktivácia komplementu, u iných nadmerná produkcia abnormálneho IgA alebo silná endotelínová odpoveď. Kombinácia liekov s rôznymi mechanizmami účinku bude pravdepodobne novým štandardom.

Záver

Nové liečebné možnosti v oblasti IgA nefropatie dávajú lekárom do rúk nástroje, o ktorých sme pred desiatimi rokmi len snívali. Cieľom už nie je len spomaliť ochorenie, ale čo najviac oddialiť alebo úplne zabrániť potrebe náhrady obličkovej funkcie.

Odporúčané kategórie: Nefrológia, Glomerulonefritídy, IgA nefropatia, Nové liečebné možnosti | Kľúčové slová: IgA nefropatia, proteinúria, eGFR, iptacopan, sibeprenlimab, sparsentan, atrasentan, budesonid, APRIL, komplement, glomerulonefritída

Zdroj a inšpirácia:
Spracované podľa článku: IgA Nephropathy: Advances Drive a Wave of New Therapies, Medscape, 2026. Dostupné online: https://www.medscape.com/viewarticle/iga-nephropathy-advances-drive-wave-new-therapies-2026a1000fdl

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-nove-cielene-terapie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.